

ALEXANDER BERKI

MEDICAMENTOS:	não
SINTOMAS/QUEIXAS	não tem sintomas, já utiliza AFO.
BANHEIRO	OX
HORA QUE ACORDA	7hr por-noite (médio 08hr)
HORA QUE DORME	01 hora.
Respiração	nasal
PRÁTICA EXERCÍCIO	não faz exerc.

PLMS = 41.6
CPAP (P= 8)
SpO2 90%.

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES

CAFE: sim ALMOÇO: sim LANCHE: sim JANTA: sim

27/12/22 P= fixa.
P= 8cmH2O.

Classif. Mallamp. 3.

22/12/2023 P= 8 cmH2O docacp.
fixa.

silva

23/12/2024 P= 8 cmH2O fixa docacp

silva

Nome: ALEXANDER BERKI
Data de Nascimento: 23-9-1977
IMC: 31,10
Sexo: Masculino
Data do exame: 25-07-2022

Peso: 103 kg
Altura: 1,82 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 25-07-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 494,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 58,0 e 80,0 minutos. O tempo total de sono foi de 402,5, eficiência de 81,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,4%; estágio N2: 49,7%; estágio N3: 25,1%; sono REM: 23,9%. O índice de despertares foi de 11,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 4,3/hora, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 29 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e mínima de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 92 bpm e NREM de 58 - 98 bpm.

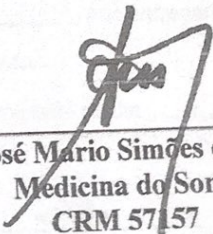
CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada e porcentagem do estágio N2 do sono NREM diminuída;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
8. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (41,6/hora);
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157